

15. SVILUPPO DELLA LINGUA E TIROIDE

DURATA : 07:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora i complessi processi di sviluppo della lingua e della tiroide durante l'embriogenesi, concentrandosi sul raddrizzamento embrionale e le sue implicazioni sulla dinamica posturale. Vengono affrontate pratiche come la stabilizzazione della lingua e l'interazione con la cartilagine tiroidea, sottolineando l'importanza delle strutture che circondano il forame cieco. Gli insegnanti esaminano anche l'impatto degli archi branchiali e dei tessuti embrionali sullo sviluppo generale, nonché l'importanza dei fulcri nel corpo, in particolare attraverso il bacino. Questi concetti sono cruciali per i professionisti che cercano di integrare un approccio olistico nel loro lavoro osteopatico.

SVILUPPO DELLA LINGUA E DELLA TIROIDE

Al momento della **flessione** e del **raddrizzamento** dell'embrione, il tubo digerente è inizialmente posizionato piuttosto in basso. Osservando il **palato**, si nota che presenta una forma ogivale, mentre in precedenza era piuttosto basso. Questo raddrizzamento è accompagnato da una **discesa dei pterigoidei** e da una trazione che fa risalire il tubo digerente.

Questo processo di sviluppo è cruciale per la formazione della **lingua** e della **tiroide**, che deriva dalla lingua. Nella sezione embrionale, si osserva la parte **endodermica** così come gli archi faringei numerati (1, 2, 3, 4). Nell'arco faringeo numero 1, al momento del raddrizzamento, appare lo **strato della lingua laterale**. Tra l'arco branchiale numero 2 e questo strato, si forma un **tubercolo impari** e un piccolo foro, il **forame cieco**.

Il forame cieco, che si sviluppa con la lingua, è essenziale per la formazione del sistema tiroideo. Questo sviluppo è caratterizzato da una **crescita globale**, con un punto fisso che agisce come un punto di appoggio. La profondità della lingua è legata alla **profondità dell'encefalizzazione**.

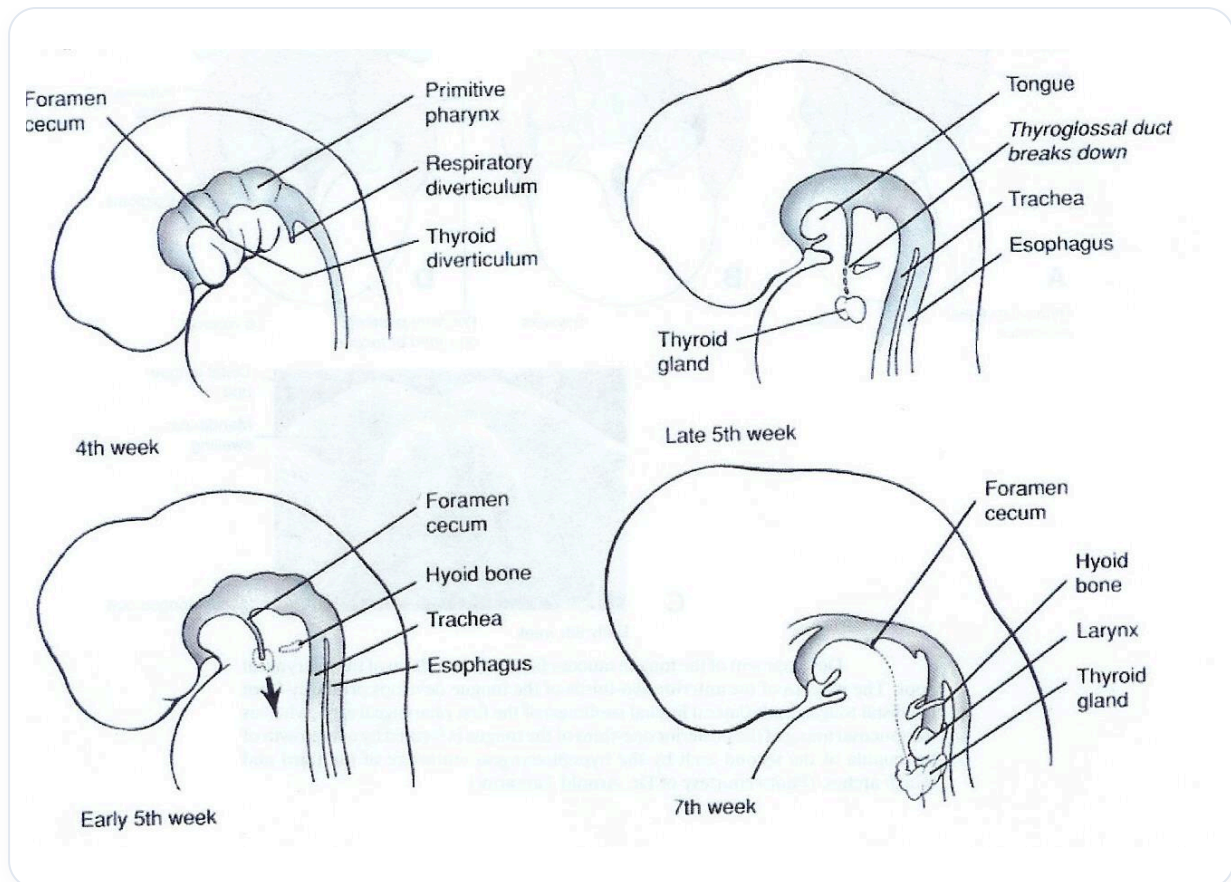


FIG. — Sviluppo tiroideo embrionale

Il raddrizzamento embrionale rivela il forame cieco, che è cruciale per la formazione delle strutture circostanti. Un'altra sezione mostra la **cartilagine di Meckel** e la lingua. È importante notare che le frecce nelle illustrazioni devono essere orientate correttamente per comprendere la dinamica di questo sviluppo.

Esiste uno strappo tra la lingua e il diaframma, dove la **cartilagine tiroidea** diventa un punto di appoggio. Stabilizzare la lingua e l'aria vaga è essenziale per mantenere l'equilibrio a livello della cartilagine tiroidea e dell'osso ioide. La lingua svolge un ruolo fondamentale nell'attività posturale, e il bambino inizia a raddrizzarsi con la comparsa dei suoi primi denti, usando la lingua come punto di appoggio.

La lingua cerca di **tappare i piccoli fori** durante la deglutizione, e il suo movimento può influenzare l'asse longitudinale del corpo, arrivando fino al **bacino**. Deviazioni del bacino possono essere il riflesso di uno squilibrio occlusale, legato alla dinamica linguale.

I denti sono zone di **densificazione** e possono conservare delle memorie, il che influenza la dinamica corporea. In questa fase di sviluppo, si osservano anche le **tonsille palatine**, la **paratiroide**, il **timo**, e il **corpo ultimobranchiale**. Ogni arco branchiale (mandibolare, tiroideo, laringeo superiore e inferiore) è interconnesso, e il tessuto endodermico svolge un ruolo centrale in questa dinamica.

Lo sviluppo embrionale si svolge in un periodo specifico, con la **chiusura del tubo neurale** al 27° giorno e il raddrizzamento completo dell'embrione dopo il primo mese. La formazione dell'embrione è completata tra il secondo e il terzo mese, con strutture ben definite.

I tessuti embrionali si influenzano reciprocamente: l'**ectoderma** e l'**endoderma** dipendono dal **mesoderma**, che assicura la trasmissione delle informazioni nutritive. Questa dinamica è essenziale per comprendere lo sviluppo della lingua, della tiroide e della paratiroide.

È cruciale seguire i **fulcri** nel corpo, poiché si manifestano nella pratica. L'**ombelico** è un grande fulcro, ed è essenziale che il bacino sia libero e sgombro per un buon funzionamento. Nella pratica osteopatica, il trattamento del bacino è spesso una priorità, poiché è legato alla **sinfisi sfeno-basilare**. Lavorare sul sacro o sul bacino influenza direttamente questa sinfisi, permettendo così un approccio olistico al corpo.

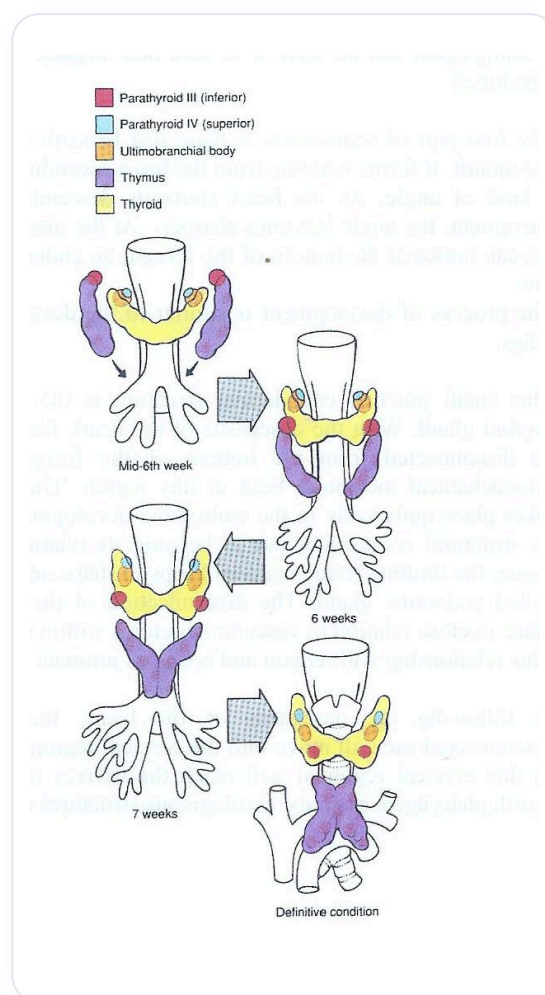


FIG. — Sviluppo tiroide e paratiroide

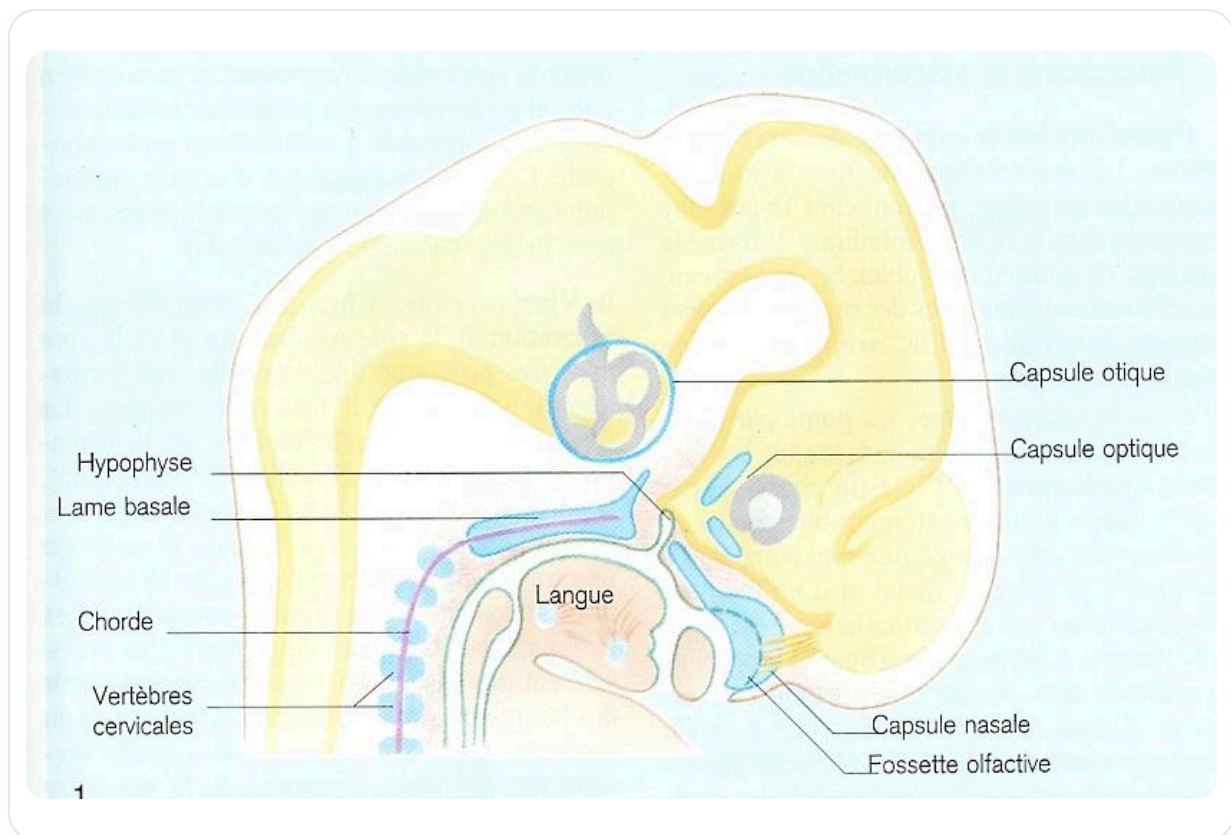


FIG. — *Embrione umano sagittale*

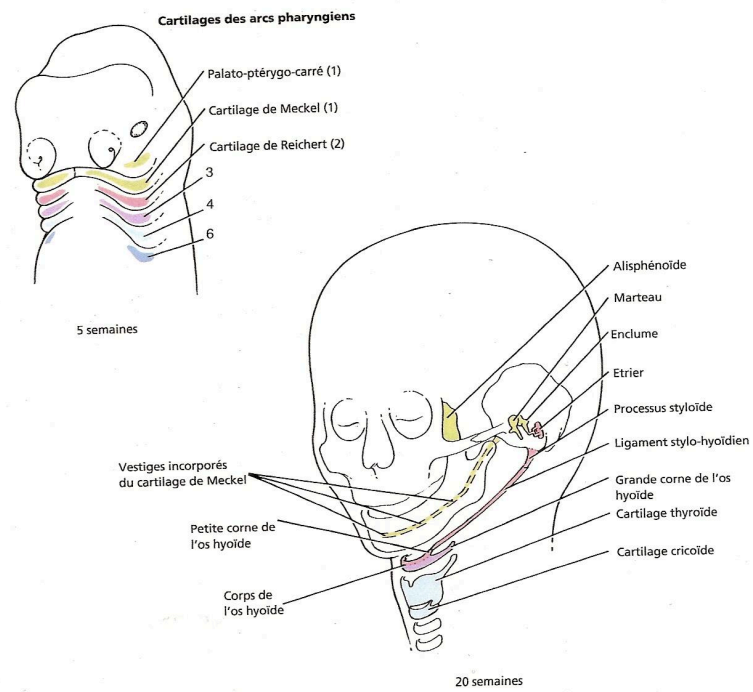


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

FIG. — Sviluppo archi faringei

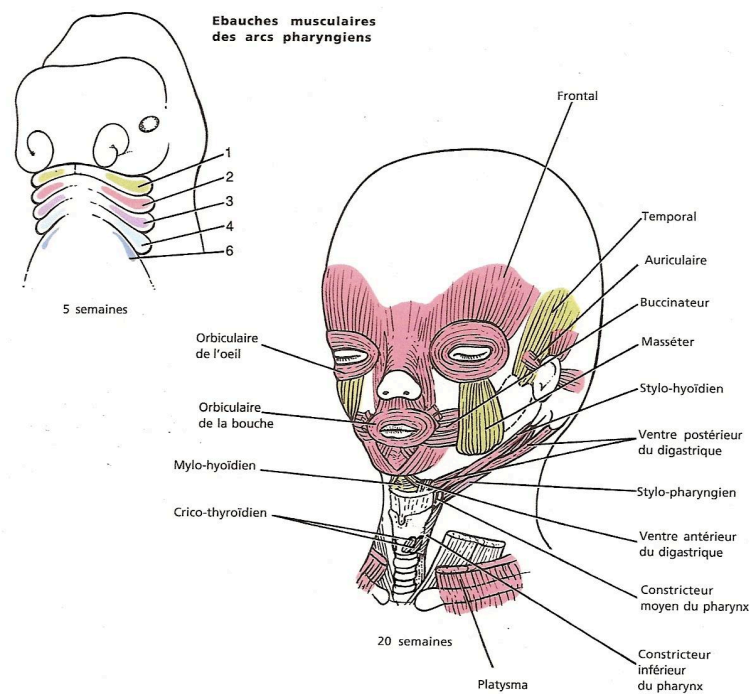


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

FIG. — Muscolatura archi faringei

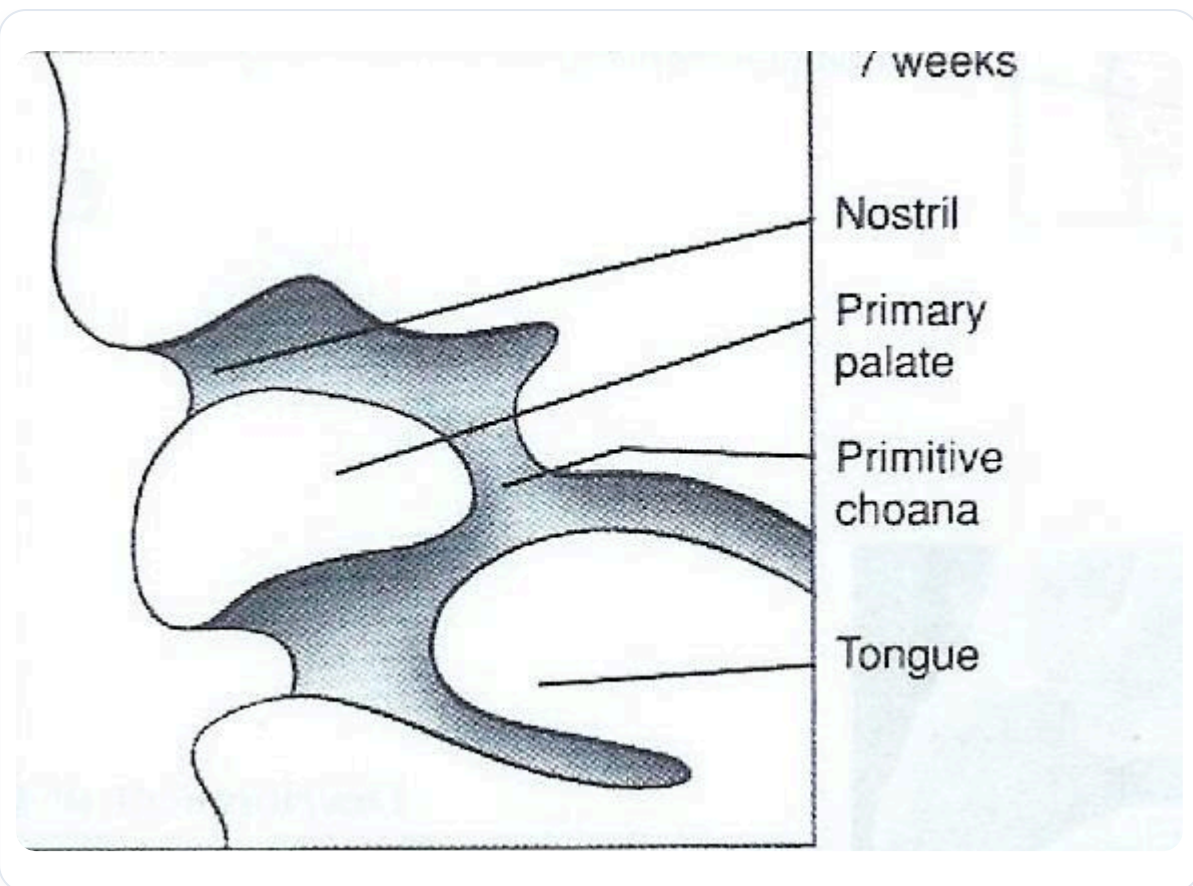


FIG. — Sviluppo palato embrione

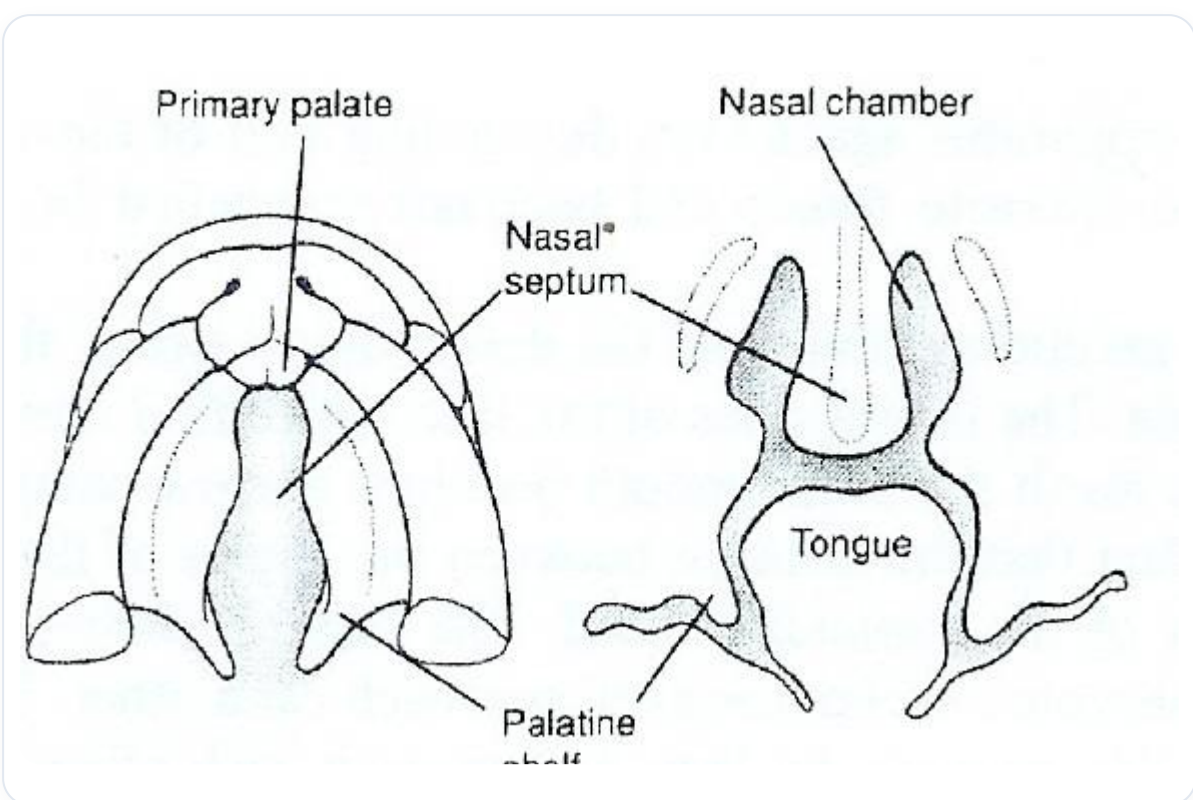


FIG. — Sviluppo palato e naso

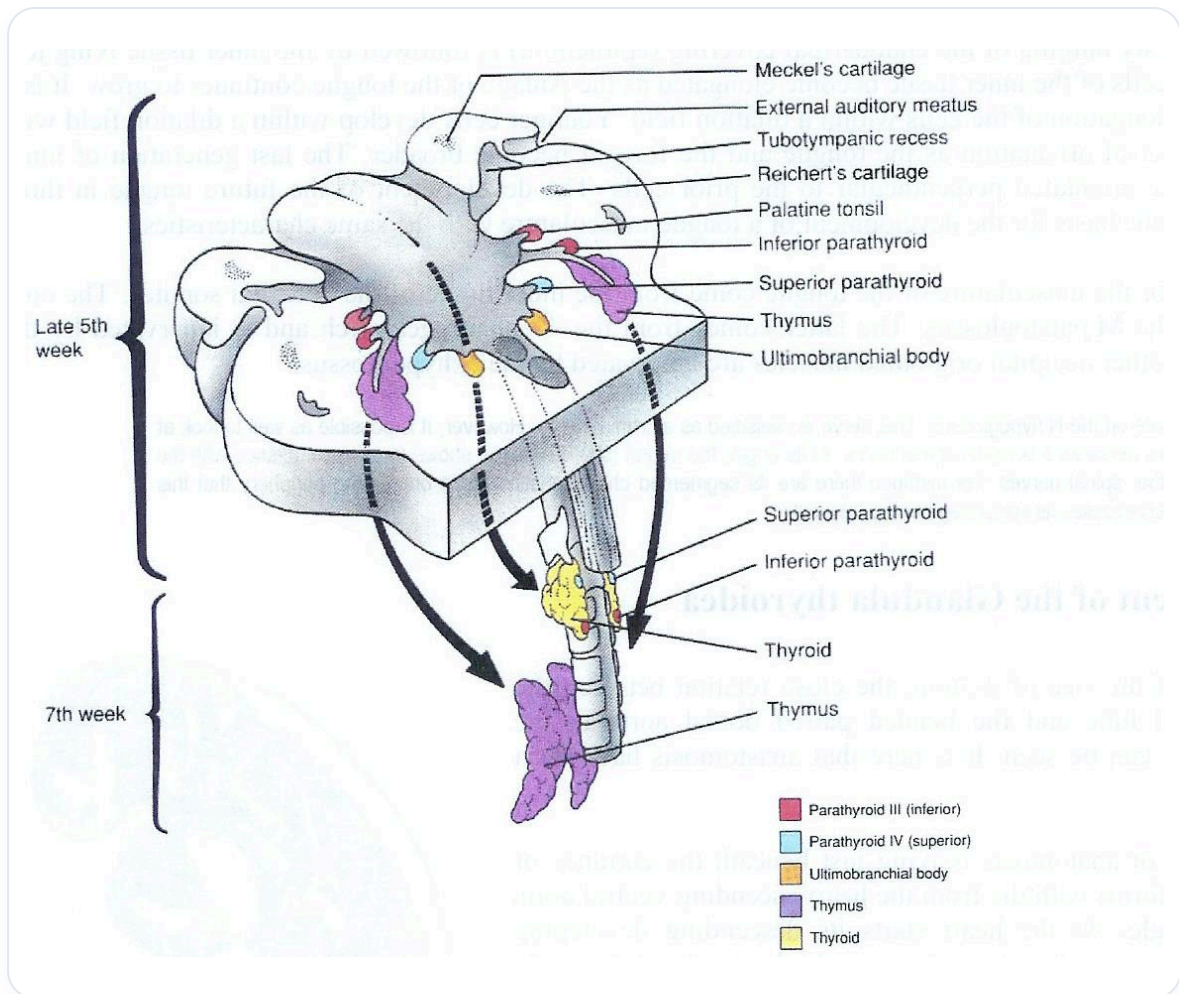


FIG. — Sviluppo faringeo